

KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

ANALISTA SANITARIO

Bisogni di salute e indicatori

Il kit dell'analista sanitario

Materiale didattico — Workshop KIREO

Apri un'enoteca a Centocelle, Roma

Cosa devi produrre

Prima di decidere cosa offrire, bisogna sapere di cosa ha bisogno questa popolazione. E dopo un anno bisogna dimostrare che il presidio ha funzionato. Il tuo lavoro è costruire il profilo di salute della comunità e definire gli indicatori di risultato.

La consegna richiesta

- Profilo demografico e di salute della popolazione servita
- Stima dei bisogni: quanti cronici, quali patologie, quale carico assistenziale
- Set di indicatori per valutare il presidio dopo 12 mesi
- Come si raccolgono i dati senza appesantire il lavoro clinico

Il contesto delle aree interne in Italia

Questi dati inquadrano il fenomeno con cui il presidio ha a che fare. Non sono numeri astratti: descrivono esattamente la situazione della dottoressa.

Indicatore	Dato	Implicazione
Comuni aree interne in calo demografico entro 2043	oltre 82%	Nel Mezzogiorno si arriva al 93%
Comuni italiani con zero nascite nel 2024	358	Quasi tutti nelle aree interne
Rapporto over 65 / under 15 nei comuni ultraperiferici	~2,5 a 1	Popolazione fortemente sbilanciata verso l'età anziana
Età media della popolazione servita	54 anni	Dato del brief: molto sopra la media nazionale
Distanza dall'ospedale più vicino	45 minuti	D'inverno anche un'ora. Barriera reale all'accesso

Fonti: proiezioni ISTAT su comuni delle aree interne; Piano Strategico Nazionale Aree Interne; progetto Age-it coordinato dall'Università del Molise, finanziato PNRR, che sperimenta telemedicina e monitoraggio remoto in questi territori.

Stimare i bisogni: da 3.200 abitanti a numeri utili

Con l'età media dichiarata puoi stimare la prevalenza delle principali condizioni croniche. Questi sono i tassi con cui ragionare.

Condizione	Prevalenza over 65	Stima sulla popolazione	Carico assistenziale
Iperensione arteriosa	~50–60%	Da calcolare	Controlli periodici, aderenza terapia
Diabete tipo 2	~18–20%	Da calcolare	Glicemia, piede diabetico, screening complicanze
Scompenso cardiaco	~10–15%	Da calcolare	Peso, pressione, saturazione: alto rischio ricovero
BPCO	~10–12%	Da calcolare	Spirometria, ossigeno, riacutizzazioni invernali
Pluripatologia (3+ croniche)	~25–30%	Da calcolare	I pazienti che assorbono più risorse

Il tuo lavoro: applica questi tassi alla fascia over 65 della popolazione servita e ottieni una stima del numero di pazienti per patologia. Sono i numeri che dimensionano il presidio.

Gli indicatori per dire se ha funzionato

Indicatore	Come si misura	Perché conta
Accessi al presidio	Conteggio prestazioni per tipo	Misura base di utilizzo
Pazienti in telemonitoraggio	N. attivi / N. eleggibili	Tasso di adesione reale
Accessi al pronto soccorso	Confronto anno precedente	L'indicatore più forte: meno urgenze evitabili
Ricoveri per riacutizzazione	Da dati ASL	Dimostra l'efficacia clinica del monitoraggio
Aderenza terapeutica	Da prescrizioni farmaceutiche	Effetto dell'educazione terapeutica
Km evitati dai pazienti	Prestazioni erogate × distanza ospedale	Impatto concreto e comunicabile
Soddisfazione degli assistiti	Questionario breve, 3–5 domande	Da somministrare di persona, non online

Le domande che la dottoressa ti farà

- "Questi dati chi li raccoglie? Io non ho tempo per compilare tabelle."
- "Come faccio a sapere quante persone hanno il diabete? Non ho un registro."
- "Se dopo un anno i numeri non sono buoni, chiudono il presidio?"
- "I dati dei pazienti dove finiscono? Chi li può vedere?"
- "A cosa mi serve sapere che ho evitato 40 ricoveri? A chi lo dico?"

Prossimo passo — costruisci il profilo di salute e il set di indicatori, poi vai nella chat. Attenzione: la raccolta dati non deve pesare sul lavoro clinico.